

17 - 03-Les angines - Pr. TASSI

(0:02 - 0:43)

Bonjour, on va voir aujourd'hui le cours des angines. Les objectifs de ce cours c'est de définir le mot angine, examiner une gorge, citer les signes cliniques et les complications d'une angine, de décrire les différents types d'angines et leurs agents pathogènes et de décrire les différentes étapes d'un test rapide. Un rappel anatomique, on voit ici les amygdales en rouge entre le pilier antérieur et l'oropharynx.

(0:44 - 6:55)

Toute cette région là, quand il est inflammé, est appelée angine ou amygdale. Alors on appelle pharyngite, une inflammation de l'oropharynx qui va s'étendre des piliers antérieurs qui vont couvrir en avant les amygdales jusqu'à la paroi postérieure de l'oropharynx. Et on appelle angine si l'inflammation ou l'infection de l'oropharynx qui touche les amygdales.

Donc le mot angine, il est égal aux amygdalites, il est égal aux pharyngites, il est égal aux pharyngo-amygdalites. Les angines, elles vont se manifester par une fièvre dont l'intensité est variable, d'une douleur pharyngique qui est une douleur constructive, spontanée, unie aux bilatérales et qui peut être augmentée par la déglutition, c'est ce qu'on appelleodynophagie. Et plus rarement, on peut avoir des auralgies, on peut avoir des vomissements et des douleurs abdominales, surtout chez l'enfant, et qui peuvent même être révélatrices de l'angine.

Donc l'intérêt d'examiner la gorge chez un enfant, souvent c'est d'autres signes qui vont les révéler. Alors physiquement, pour examiner la gorge, il faut se mettre devant le patient, il faut avoir une source lumineuse, sinon utiliser la lumière du jour ou la lumière de la salle, et être en face du patient, lui demander d'ouvrir bien sa bouche, de faire sortir la langue et même de prononcer la lettre A en la prolongeant pour dégager la référence. Il faut apprécier l'aspect des amygdales, leur taille, il faut aussi chercher les adénopathies satellites en examinant le cou, en cherchant les adénopathies, les différents vaisseaux lymphatiques.

Il faut terminer avec un examen général, en cherchant, en prenant la température du patient, en réalisant un examen cutanéomique, chercher une spiruline élargie, faire une auscultation cardiaque. Différents types d'angines sont possibles. On a les angines érythémateuses, les angines érythématopultacées, les angines pseudomembraneuses, les angines vésiculeuses et les angines phlegmoneuses.

Alors commençons par les angines érythémateuses et elles vont se manifester par un aspect d'amygdale très augmenté de taille avec un aspect rougeâtre. Par contre, les angines érythématopultacées sont couvertes avec un enduit pultacé. Vous voyez, c'est à droite désigné par des flèches.

Il s'agit d'un exudat gris jaunâtre, ponctiforme ou entraîné, mince et friable, c'est-à-dire qu'on

peut l'enlever par des abaisse-langue mais qui ne déborde pas la surface amygdalia, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve que à la surface des amygdales. La cause de ces angines erythématopultacées, dans la majorité des cas, est due à des virus. Dans à peu près 30% des cas, la cause est due à une bactérie dominée par le streptococque du Group A. Pour faire la part entre la cause bactérienne et la cause virale, on n'en a pas plusieurs solutions.

Soit on réalise un prélèvement de la gorge qu'on va adresser au laboratoire et ce n'est pas du tout pratique parce que c'est coûteux, soit on réalise un test de diagnostic rapide. Malheureusement, ce type de test-là, on ne l'a pas disponible aux marques. Alors, comment on réalise ce test-là ? C'est une forme d'un nicovillant avec un coton à l'extrémité qu'on va aller directement vers les amygdales en évitant de toucher les dents, les gencives, les joues et la langue pour ne pas être contaminé avec les germes de la cavité buccale.

On va le mettre à la surface des amygdales, l'entourer à la surface pour racler les germes des amygdales, utiliser un réactif qu'on va mettre dans le tube et puis il faut introduire le nicovillant à l'intérieur, agiter la solution puis attendre une minute et presser le coton, ce coton-tige, ce nicovillant au niveau de la surface du tube pour exprimer la solution avec les germes qui sont au niveau de ce bout de coton. Et par la suite, on va mettre une bandelette dans le tube avec une flèche vers le bas et lire après cinq minutes de réaction. Alors vous avez ici trois bandes, normalement il faut avoir une bande qui doit être présente toujours et c'est la bande rouge qui témoigne de la validité de la technique, la validité du test et si cette bande-là n'est pas présente, on ne peut pas retenir le résultat, quel que soit le résultat de la bande.

Donc si on a deux bandes, la bande de validité rouge et la bande et l'autre bande du patient, le test est considéré comme positif et dans ce cas-là c'est l'agent bactérien qui est responsable. Si le résultat, on obtient seulement le test, la bande de validité sans bande du patient, le test est considéré négatif. Si on n'a pas de bande de validité, le résultat est considéré comme invalide et dans ce cas-là il faut refaire le prélèvement.

(6:56 - 10:53)

Un deuxième type d'angine, ce sont les angines pseudomembraneuses. Elles sont caractérisées par des angines, des amygdales augmentées de taille, rougeâtres, mais elles sont couvertes avec des enduits blanchâtres. Ces différents des angines erythématopultases sont des enduits blanchâtres comme du coton à la surface de ces amygdales.

Elles peuvent même parfois déborder en fonction de l'éthiologie. Deux étiologies principales devant des angines pseudomembraneuses, il y a une cause virale qui est la mononucléose infectieuse qui est due à un virus, c'est le virus d'Epstein-Barr virus, et qui va donner des fausses membranes non adhérentes respectant l'aluède avec un purpuraduboil du palais, des adénopathies d'effusions particuliers cervicales, une sphérie amygdale profonde, et dans ce cas-là, le diagnostic positif est posé par le éminé-test ou par la sérologie. Deuxième cause, c'est la diphtérie, et c'est grâce à la vaccination qu'il a été éradiqué de notre territoire, donc il n'y a plus de diphtérie chez nous, et c'est une bactérie, c'est le Cerenobacterium diphtérie, et dans ce cas-

là, il faut suspecter le diagnostic quand il n'y a pas la vaccination contre la diphtérie, quand on a des fausses membranes extensives, adhérentes et cohérentes, envahissant même l'aluède, quand il y a des adénopathies sous-maxillaires avec un choréza unilatéral, une pâleur et un tachycardie, et le diagnostic positif est posé par le prélèvement de gorge qui va mettre en évidence le *Cerenobacterium* diphtérie.

Autre type d'angine, c'est l'angine ulcéronécrotique. Il s'agit d'une angine ulcérée, c'est-à-dire avec une perte de matière, il peut s'agir d'une seule ulcération de plusieurs, d'une atteinte d'un seul amygdale ou de deux amygdales. Quand il s'agit d'une atteinte bilatérale, il faut penser essentiellement à une hémopathie, une maladie de sang maligne.

Quand il s'agit d'une forme unilatérale, il y a deux principales étiologies. Il y a l'angine Vincent, c'est une angine qui est due à une association fuso-spirulaire de germes et qui se voit essentiellement en cas d'hygiène défectueuse de la bouche, chez des gens aussi fumeurs et avec une mauvaise haleine de la bouche. Et aussi la deuxième cause, c'est la syphilis.

Donc c'est essentiellement les gens qui pratiquent le sexe oral. Les angines vésiculeuses, ce sont des angines d'origine toujours virale. On a le pharynx qui est rouge vif avec présence de vésicules et différents virus peuvent être responsables, comme coxsacivirus, l'herpes simplex virus.

L'angine phlegmoneuse, c'est une complication d'angines bactériennes avec réalisation de phlégmons périhamidaliens. Donc l'agent responsable, c'est essentiellement le streptococque de groupe A avec les anaérobies et il va donner une douleur pharyngée très importante, unilatérale, intense, avec même autalgie très smooth, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche. C'est une limitation douloureuse de la bouche, mais unilatérale, différences de tétanos qu'on va voir l'année prochaine, une fumifaction très importante, un bandement unilatéral du voile de palais avec un état général très altéré, une température très élevée vers 39-40.

Et dans ce cas-là, c'est l'indication d'un drainage de la mygdale avec un traitement antibiotique.